

Lactancia materna: beneficios, técnica y contraindicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

La **lactancia materna (LM)** es el método de alimentación ideal para el recién nacido y lactante, y constituye la estrategia de salud pública más costo-efectiva para mejorar la supervivencia infantil. La **OMS** y el **MINSAL** recomiendan **lactancia materna exclusiva (LME)** durante los **primeros 6 meses de vida**, y su continuación junto a alimentación complementaria hasta los **2 años o más**.

En Chile, la LM es pilar central del **Programa Nacional de Salud Infantil** y del **Chile Crece Contigo**, con cobertura universal en todos los controles de niño sano. Los profesionales de salud deben conocer su fisiología, técnica, beneficios, manejo de dificultades y contraindicaciones reales, dado que **el EUNACOM** evalúa este tema con frecuencia en preguntas sobre **apoyo a la lactancia, causas de fracaso o sustitución inadecuada por fórmula**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Fisiología de la lactancia

El proceso de lactancia involucra tres etapas fisiológicas:

1. Lactogénesis I (prenatal):

- Desde el 2º trimestre, los niveles altos de estrógenos, progesterona y prolactina estimulan el desarrollo alveolar mamario.
- Se produce **calostro** antes del parto.

2. Lactogénesis II (posparto inmediato):

- Tras la expulsión de la placenta, caen los niveles de estrógeno y progesterona, permitiendo la acción de la **prolactina**, que inicia la **secreción láctea abundante** (48–72 h posparto).

3. Galactopoyesis y eyección:

- La **prolactina (adenohipófisis)** estimula la producción de leche en respuesta a la succión.

- La **oxitocina (neurohipófisis)** provoca contracción de las células mioepiteliales, facilitando la **eyección láctea**.
- La succión frecuente y eficaz es el principal estímulo para mantener la producción.

b. Composición de la leche materna

La leche materna se adapta dinámicamente a las necesidades del lactante:

Tipo de leche	Características
Calostro (0–5 días)	Amarillento, espeso, alto en proteínas e inmunoglobulinas (IgA), bajo en grasa. Efecto laxante y protector intestinal.
Leche de transición (5–15 días)	Aumento de volumen y grasa; disminuye proteína.
Leche madura (>15 días)	Contiene 87% agua, 7% lactosa, 4% lípidos, 1% proteínas, vitaminas, minerales y anticuerpos.
Leche del inicio (foremilk)	Más líquida, rica en lactosa y agua (hidrata).
Leche del final (hindmilk)	Mayor contenido graso (sacia y favorece ganancia de peso).

c. Factores que influyen en la producción

- **Frecuencia de succión:** principal regulador (demanda-oferta).
- **Contacto piel a piel inmediato.**

- Estado emocional y descanso materno.
 - Hidratación y nutrición adecuada.
 - Evitar uso innecesario de fórmula o chupete, que disminuyen el estímulo de succión.
-

3. Clínica: técnica de lactancia y problemas frecuentes

a. Técnica correcta de lactancia

1. Posición adecuada:

- Madre cómoda, espalda apoyada, bebé frente al pecho (“vientre con vientre”).
- Cabeza y cuerpo del lactante alineados.
- Nariz a nivel del pezón.

2. Agarre efectivo:

- Boca bien abierta.
- Labio inferior evertido.
- Mentón tocando el pecho.
- Se observa succión rítmica y profunda, sin dolor ni chasquidos.

3. Duración y frecuencia:

- A libre demanda, día y noche (8–12 veces al día).
- No limitar tiempo: el niño regula inicio y fin de la toma.
- Ofrecer ambos pechos alternadamente.

4. Signos de lactancia eficaz:

- Aumento de peso adecuado.
- Micciones ≥ 6 veces al día.

- Niño tranquilo tras la toma.
- Pechos suaves después de amamantar.

b. Posiciones comunes

- **Cuna tradicional:** bebé sobre el antebrazo del mismo lado del pecho.
- **Posición cruzada:** cabeza del bebé sostenida por la mano opuesta al pecho ofrecido (favorece agarre en recién nacidos pequeños).
- **Posición acostada:** útil para madres cansadas o cesárea.
- **Posición “balón de rugby”:** útil en cesárea o gemelares.

c. Problemas frecuentes y manejo

Problema	Causa	Manejo
Pezones doloridos o agrietados	Mal agarre	Corregir técnica, aplicar leche materna sobre pezón, airear, evitar jabón.
Ingurgitación mamaria	Retención de leche	Amamantamiento frecuente, extracción manual, compresas tibias antes y frías después.
Mastitis	Infección por <i>Staphylococcus aureus</i>	Continuar lactancia, vaciar mama afectada, antibióticos (dicloxacilina o cloxacilina 10–14 días).
Obstrucción de conducto	Succión ineficaz o presión local	Masaje, calor local, variación de posición.

Disminución de producción	Poca succión, estrés, uso de fórmula	Aumentar frecuencia de tomas, contacto piel a piel, reposo, hidratación.
Rechazo del pecho	Dolor, congestión, confusión por mamadera	Corregir técnica y evitar biberones.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de dificultades en la lactancia es **clínico y observacional**, mediante la evaluación de:

1. Aumento de peso del lactante:

- Pérdida fisiológica hasta 10% del peso al nacer durante los primeros 5 días.
- Recupera el peso al nacimiento hacia el día 10–14.
- Aumento promedio: 150–200 g/semana (0–3 meses).

2. Observación de la toma:

- Evaluar postura, agarre, succión, deglución y eyección.

3. Control de eliminación:

- Diuresis y número de deposiciones.

4. Valoración del vínculo madre-hijo y factores emocionales.

En casos de mala ganancia ponderal, debe evaluarse alimentación, descartar infección, cardiopatía o trastorno metabólico, pero **nunca suspender la lactancia sin causa médica justificada**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

a. Indicaciones generales (Norma Técnica de Lactancia Materna, MINSAL 2018)

Situación	Conducta recomendada
Lactancia exclusiva (0–6 meses)	Solo leche materna; no agua, té ni jugos.
Lactancia predominante (≤ 6 meses)	Puede incluir pequeñas cantidades de otros líquidos, pero sin fórmula.
Lactancia mixta	Se usa solo si la madre no logra LM exclusiva tras apoyo especializado.
Continuación (6–24 meses)	Mantener LM junto a alimentación complementaria.

b. Estrategias de apoyo

- Contacto piel a piel inmediato y alojamiento conjunto.
- Inicio de lactancia en la primera hora posparto.
- Evitar fórmulas o chupetes de rutina.
- Educación prenatal y postnatal.
- Grupos de apoyo a la lactancia (CESFAM, La Liga de la Leche, Chile Crece Contigo).

c. Manejo farmacológico en casos especiales

- **Mastitis bacteriana:** dicloxacilina o cefalexina por 10–14 días; continuar lactancia.
 - **Dolor intenso o grietas:** analgésicos (paracetamol o ibuprofeno).
 - **Galactorrea o hipogalactia persistente:** domperidona puede considerarse en casos seleccionados bajo control médico.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Consecuencia	Prevención / Manejo
Abandono precoz de LM	Mayor riesgo de infecciones, alergias y obesidad	Educación y apoyo activo
Mastitis o absceso mamario	Dolor, fiebre, suspensión temporal	Continuar vaciamiento, antibióticos
Malnutrición del lactante	Falla de crecimiento	Supervisión técnica y controles periódicos
Engurgitación crónica	Dolor, grietas, congestión	Lactancia frecuente y libre demanda
Dificultades psicológicas	Depresión posparto, ansiedad	Apoyo emocional, red ChCC

El pronóstico de la LM es excelente si se inicia precozmente y se cuenta con apoyo profesional continuo. En Chile, las tasas de LME a 6 meses superan el 50% en muchos CESFAM gracias al **Programa Chile Crece Contigo**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses** y continuada hasta los **2 años o más**.
2. La **técnica y el agarre** son los determinantes más importantes del éxito.
3. La **mastitis no contraindica la lactancia**; debe continuarse.
4. La **producción se regula por la demanda**, no por el volumen ingerido.

5. La **leche materna varía dentro de la misma toma**: la del final es más grasa.
6. **El uso precoz de fórmula o chupete** interfiere con el reflejo de succión y reduce la producción.

❑ **Errores frecuentes:**

- Indicar agua o té a menores de 6 meses.
- Suspender LM por mastitis o grietas leves.
- No ofrecer ambos pechos o limitar tiempo de succión.
- Usar “galactogogos” sin corregir primero la técnica.
- No registrar ni seguir la ganancia de peso adecuadamente.

8. Contraindicaciones de la lactancia materna

a. Absolutas (raras)

Situación	Justificación
Infección materna por VIH (en Chile, si acceso seguro a fórmula)	Riesgo de transmisión vertical
Galactosemia clásica del lactante	Incapacidad para metabolizar galactosa
Uso materno de drogas ilícitas activas (cocaína, anfetaminas)	Riesgo de toxicidad en el lactante
Radioterapia o quimioterapia activa	Excreción de citotóxicos en la leche

b. Relativas (según situación clínica)

Situación	Conducta
Tuberculosis materna activa sin tratamiento	Suspender temporalmente hasta 2 semanas de tratamiento.
Herpes simple en pezón	Suspender lactancia del pecho afectado.
Varicela materna 5 días antes o 2 días después del parto	Aislamiento y LM con precaución.
Hepatitis B o C	No contraindica; continuar LM.
Uso de medicamentos potencialmente tóxicos	Consultar base de datos “LactMed” o manual MINSAL de fármacos en lactancia.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses** es el estándar de oro nutricional y de salud pública.
2. La **técnica correcta y el agarre eficaz** determinan el éxito y previenen complicaciones.
3. La **producción de leche se regula por la succión frecuente y efectiva**.
4. La **mastitis no contraindica la lactancia**; debe continuarse con tratamiento.
5. Las **contraindicaciones absolutas son excepcionales** (VIH, galactosemia, drogas ilícitas).
6. El **apoyo continuo a la madre y familia** mejora la adherencia y duración de la LM.
7. El **MINSAL y Chile Crece Contigo** promueven la lactancia como parte integral del control de salud infantil.